جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ياسمين احمد صالح محمود

العنوان : 30ش كمال الساعاتى ارض ابوسعدة شبرا الجيمة القليوبية

المحافظة : القليوبيه **الحي / المدينة :** شبرا الخيمه

رقم البطاقة : 27708061401223 **رقم التليفون :** 01126377127 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 23-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 06-08-1977 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع:(----------)

المقر بما فيه
التوقيع:(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ياسمين احمد صالح محمود
National ID: 27708061401223

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
ياسمين
احمد صالح محمود
٣٠ ش كمال انساعاتى-أرض
شبرا الخيمه ثان - القليوبية
٢٧٧٠٨٠٦١٤٠١٢٢٣
JK3463542


٢٧٧٠٨٠٦١٤٠١٢٢٣ ٢٠٢٢/٠٥
حاصله على بكالوريوس تجاره
أنثى مسلمة متزوجة
وليد ابراهيم رضوان السمان
١١
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٥/٢٩

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	: الأستاذه / ياسمين احمد صالح محمود	Request No.	: 13006068
Patient No.	: 27708061401223	Request Date	: 22/01/2025
Path No.	: 295/25	Verification Date	: 03/02/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 47 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

* Ductal carcinoma in situ: Positive DCIS 15% (comedo, cribriform).
* Resection margins: Free margins.
* Lymph node involvement: Free SLNs (0/4).
* Microcalcifications: Positive.
* Additional pathologic findings: Sclerosing adenosis, usual ductal hyperplasia.

Diagnosis:
Left breast cancer, Up-Front, BCS & SLNs, Up-front:
Invasive duct carcinoma, Grade II, with DCIS (comedo, cribriform).
Free margins.
Free lymph nodes (SLNs 0/4).
Stage: pT2, pN0

Signature
Dr.Salma Tarek.
Dr.Samia Ali.

Verified by :
Dr.Toka Medhat

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: ياسمين احمد صالح **MR. :** 183	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient has a history of left-breast invasive ductal carcinoma (IDC) with associated DCIS, luminal A subtype. The patient underwent left breast-conserving surgery with sentinel lymph node biopsy in January 2025, achieving free margins and revealing 0/4 positive nodes (T2N0). A port was placed, and adjuvant chemotherapy was completed, followed by hormonal therapy with tamoxifen initiated in June 2025. The most recent breast-surgical margin assessment was performed in February 2026 via pelvic-abdominal ultrasound. The patient presented today for tamoxifen refill and a three-month supply from the pharmacy.

A contrast-enhanced CT of the chest, abdomen, and pelvis demonstrated subpleural nodules that are likely metastatic, with differential consideration of left adrenal gland hyperplasia versus metastasis; further evaluation with PET-CT was recommended.

A PET-CT performed on 6 August 2026 showed no subpleural nodules. The patient continues tamoxifen therapy with a three-month supply.

تحريرا في ,

التاريخ :	**19-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : **mohamed ismael**

يعتمد ,

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Yasmin Ahmed Saleh Mahmoud	Date : 15/12/2024
Exam.: C.T CHEST	Age : 47 Year(s)
Medical ID: 4540/2024	Pat. ID: 95415

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

**Newly discovered breast cancer

I Chest:-

- Bilateral more at the Right breast parenychamal distortion with minimal right breast diffuse skin thickening.
- Prominente bilteral axillary lymph nodes.
- Right apical reticulondular infiltrations with small cavitary nodule ablut 1.5x1 cm is seen.
- Tiny calcified nodule 2-3 mm at right lower lobe lateral segment .
- ***Otherwise*** ,Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions
- No patholcgical enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver enlarged with low homogenous CT texture. No definte focal lesions (on non contrast base) or contour irregularities.
- Lamellated calcfied stone within the gall bladder
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

*Scanned skeleton:

Degenerative spondylodegenerative changes osteophytic lipping of Dorsal vertebrae from D6 to D10. ***Otherwise***, no definite worrisome lytic focal lesions.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Palestinian Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : [illegible]
Sex: Female
3- Medical number: 83249389
Old Med : 4426-2024
2-ID number:
Patient Age : 48 Y

Family history		Phone	01120870335	BMI		REASON OF MDT	
marital status		NRS Score		GROUP		Date of MDT	13/02/2025
Co morbidity		Menopausal status		Initial STAGE			

Clinical data

Breast Imaging :
at 11-12 oclock 20x15 mm- 7.5 from nipple
ill defined lesion 1.2x1.3 and 1.7 from index
central and chest wall lesion 35.10

Mets Workup :
non contrast cap: old tubuculus lesions

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
IDC	8/8	8/8	0		10

T	N	M
2	0	0

Sonomammography
cesm: it UIQ 1.6x2 AT 12OCLOCK AND 8.2 from nipple , ANTHER TINY LESION 1 cm LATERAL to index lesion

PATIENT HISTORY
upfront LT BCS+SLNB:free margin PT2(3CM),LN 0/4

MDT OUTCOME & PLAN

1-ADJUVANT TC X4
2- PORT
3- ADJUVANT TAM THEN SWITCH

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Yasmin Ahmed Saleh Mahmoud	Date : 15/12/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 47 Year(s)
Medical ID: 4540/2024	Pat. ID: 95415

Opinion:

- Bilateral more Right breast asymmetrical parnchymal distortion , For sono mammography correlation
- Right apical reticulondoular infiltrtation with small cavitary ndule and right Lower lung lobe tiny partially calfied nodule, likely sequence of old tuberculous infection with suspected acute exacerbation on top, for clinical and lab correlation, and close follow up.
- Mild Hepatomegally
- No hepatic or osseous worrisome metastatic lesions on on contrast basis.

Dr Ahmed Saeed Ali

Dr. Walid Mohamed, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]